

CÓLICO BILIAR

Cristina Ferrero Sanz, Diana João Matias, Laura Rodríguez Martín.

INTRODUCCIÓN

Se define como el dolor brusco, intenso de intensidad creciente, localizado en hipocondrio derecho y/o epigastrio, pudiendo irradiarse a espalda y hombro derecho, generalmente desencadenado por la ingesta de comidas copiosas, acompañado de náuseas o vómitos biliosos

Cólico biliar simple: Obstrucción transitoria (generalmente < 6h) de la vía biliar, el dolor es autolimitado. El dolor cede espontáneamente o con analgesia y generalmente los análisis de sangre son normales.

Cólico biliar complicado: Obstrucción prolongada de la vía biliar que produce complicaciones inflamatorias e infecciosas como la colecistitis aguda, colangitis o pancreatitis. Mejoría parcial del dolor con los analgésicos.

DIAGNÓSTICO

- **Clínico:** dolor en hipocondrio derecho o epigastrio de inicio brusco irradiado a espalda y/o hombro derecho, acompañado a veces de náuseas y vómitos, sin fiebre.
- **Analítica sanguínea:** hemograma, coagulación básica (si toma de ACOs/sintron), bioquímica con glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, calcio, cloro, GOT, GPT, LDH, amilasa, bilirrubina, PCR. Se puede encontrar elevación de pruebas de función hepática, amilasa, bilirrubina (si aumentada sospechar coledocolitiasis) y LDH.
- **Sistémico y sedimento de orina.**
- **Radiografía** de tórax posteroanterior y lateral y radiografía simple de abdomen.
- **ECG.** Nos ayuda a descartar cardiopatía isquémica.
- **Ecografía abdominal:** si datos de cólico biliar complicado (Tabla 1)

Tabla 1. Datos de cólico biliar complicado

- Dolor abdominal >6h
- Fiebre
- Ictericia/coluria
- Confusión mental
- Alteración hemodinámica
- Murphy positivo
- Alteración analítica relevante

- **TAC:** si diagnóstico no concluyente y/o sospecha de otra patología.

TRATAMIENTO

- Dieta absoluta
- Sueroterapia y reposo
- Analgesia según escala visual analógica del dolor (EVA).
- metamizol 2g/6-8horas iv + bromuro de butilescopolamina 20mg/6h iv.
- dexketoprofeno 1 ampolla cada 8h.
- Antiemético: metoclopramida 10 mg/8h iv.

BIBLIOGRAFÍA

- M.A. Montoro Huguet; JC. García Pagán. Practica clínica en Gastroenterología y Hepatología. Vol II. 1ª ed. Madrid. CTO editorial. 2016. Cap. 53 y 57.
- F. Aguilar Rodríguez; O. Bisbal Prado; C. Gómez Cuervo; M. de Lagarde Sebastián; G. Maestro de la Calle; M. A. Pérez-Jacoiste Asín; J. Llenas García; L. Pérez Ordoño; J. Villa Santos. Manual diagnóstico y terapéutica médica 12 de Octubre. 8ªEd. Madrid. MSD. 2016. Cap. 51 y 58.
- L. Jiménez Murillo; FJ. Montero Pérez. Medicina de Urgencias. Guía terapéutica. 3ª ed. Barcelona. Elsevier. 2011. Cap. 35.